

Fallbeispiel Herr Lambrecht mit einer Linksherzinsuffizienz

Herr Lambrecht, 76 Jahre alt, wurde mit massiver Ruhedyspnoe, Asthma cardiale und Zyanose sowie einem auskultatorischen Brodeln über der Lunge in die internistische Notfallaufnahme mit dem RTW eingeliefert. Er hat einen Blutdruck von 90/50 mmHg, einen Puls von 120 Schlägen/Min und wiegt 64 kg bei einer Größe von 175 cm. Zudem ist bei dem Patienten eine KHK bekannt.

Herr Lambrecht berichtet dem aufnehmenden Gesundheits- und Krankenpfleger Roland unter großer Anstrengung, dass er in den letzten Wochen nachts immer sehr häufig auf die Toilette gehen musste und außerdem sehr müde und schlapp sei. Sein Sohn, der bei der Aufnahme anwesend ist berichtet weiterhin:

„Mein Vater lebt seit dem Tod meiner Mutter vor drei Jahren alleine in seiner großen Wohnung. Er kommt kaum raus, weil es keinen Aufzug in dem Mietshaus gibt. Früher war er Lackierer in einer großen Kfz-Werkstatt, dass hat ihm Freude bereitet. Er hat immer geraucht, sein Leben lang, eine Schachtel am Tag.

In letzter Zeit hat er ganz schön abgebaut. Früher war er immer ordentlich gekleidet, frisiert und rasiert, aber Sie sehen ja, wie er jetzt aussieht und seine Wohnung ist auch nicht besser. Wenn ich ihm keine Putzhilfe besorgt hätte, dann würde seine Wohnung völlig verwahrlosen. Aber ich kann einfach nicht immer nach ihm schauen, ich wohne zu weit weg und habe auch Familie und einen Beruf...“

Bei Herrn Lambrecht wird eine dekompensierte Linksherzinsuffizienz diagnostiziert und er wird zur Überwachung auf die Station 3 B aufgenommen. Der Patient erhält einen ZVK in die V. jugularis interna, an den sofort 40 mg Lasix® (Furosemid, Schleifendiuretikum) auf 2 ml / h über einen Perfusor angeschlossen wird. Der Stationsarzt verordnet zudem 2 l / min Sauerstoff über eine Sauerstoffbrille sowie absolute Bettruhe. Er darf täglich einen Liter Flüssigkeit zu sich nehmen und soll natriumarme Kost erhalten. Einen Dauerkatheter zur Bilanzierung lehnt Herr Lambrecht kategorisch ab.

Herr Lambrecht ist sehr unglücklich mit seiner aktuellen Situation: „Pfleger Roland, muss ich denn wirklich hierbleiben? Können Sie mir nicht was spritzen und mich wieder nach Hause schicken? Ich will nicht hier sein...“

Nach drei Tagen hat sich der Zustand von Herr Lambrecht stabilisiert. Er benötigt nicht länger den ZVK, bekommt das Lasix® oral und zusätzlich eine Tablette Digimerck® 0,1 mg (Digitalis, Herzglykosid). Den Sauerstoff bekommt er bei Bedarf. Allerdings hat er weiterhin eine Trinkmengenbeschränkung von 1 l / Tag. Der Patient ist zwar immer noch sehr schwach, kann aber zu den Mahlzeiten mit Hilfe des Pflegepersonals in einen Stuhl mobilisiert werden. Dabei entwickelt er zeitweise eine Belastungsdyspnoe mit leichter Zyanose.

Trotzdem es merklich aufwärts geht, wirkt Herr Lambrecht eher apathisch und in sich gekehrt. Als Pfleger Roland ihn morgens pflegen möchte reagiert Herr Lambrecht sehr unwirsch:

„Lassen Sie mich in Frieden! Ich will doch bloß in Ruhe gelassen werden. Ich wünschte, ich wäre zu Hause, da interessiert es auch keinen, wenn ich sterbe...“

Aufgabenstellung zum Fall

Führen Sie eine vollständige Problemanalyse durch, indem Sie alle aktuellen und potentiellen Pflegeprobleme von Herrn Lambrecht aufführen und begründen. Nehmen Sie als Ausgangslage für die Pflegeplanung die Situation aus dem Fallbeispiel ab Zeile 25.

Entscheiden Sie aus fachlicher Sicht, welches die drei wichtigsten Pflegeprobleme sind. Hierbei ist es unabhängig, ob dies aktuelle oder potentielle Pflegeprobleme sind. Relevant ist die Schwere bzw. Ausprägung des Problems bzw. das Risiko eines potentiellen Pflegeproblems.

Mit den drei wichtigsten Pflegeproblemen von Herrn Lambrecht erstellen Sie eine Pflegeplanung nach dem PE(S)R Schema. Nutzen Sie hierfür die Vordrucke auf ILISAS.